Sowie nach diesem Algorithmus eine Notarztindikation besteht, ist das gleichbedeutend mit einer Schockraumindikation.

Sollte es erforderlich sein, ist schon während des Primary Survey in angemessener Priorität eine Analgesie durchzuführen, ohne dabei lebensrettende Maßnahmen unnötig zu verzögern.

Schockraumkriterien (S3-Leitlinie Polytrauma)

A B

- Atemstörung mit Sauerstoff-Sättigung < 90 %
- Atemwegssicherung
- Atemfrequenz < 10 oder > 29 /min
- instabiler Thorax
- sonographisch Nachweis Pneumothorak (extended FAST)
- Thoraxentlastung / -Drainage

C

- Hypotonie mit systolischem Blutdruck < 90 mmHg
- Tachykardie mit Herzfrequenz > 120 /min
- Schockindex (= Herzfrequenz / syst. Blutdruck) > 0,9
- sonographisch freie Flüssigkeit im Abdomen (extended FAST)
- mechanisch instabile Beckenverletzung
- penetrierende Verletzung in Rumpf- und/oder Halsregion
- Amputationsverletzung proximal der Hände und/oder Füße
- Fraktur von mindestens 2 großen Röhrenknochen
- Verbrennung ab 20% der Körperoberfläche
- Verbrennung ab Grad II b
- Kreislaufunterstützung durch Katecholamine
- Pericardiozentese
- Anlage Tourniquet
- Verkehrsunfall mit Ejektion aus dem Fahrzeug
- Verkehrsunfall mit Fraktur mindestens eines langen Röhrenknochens
- senkrechter Sturz ab 3 m Höhe

geriatrische Patienten:

- Hypotonie mit systolischem Blutdruck < 100 mmHg
- ab Verletzung von 2 Körperregionen

D

- Bewußtseinseinschränkung mit GCS < 13
- motorische oder sensible Lateralisationszeichen

geriatrische Patienten:

- Bewußtseinseinschränkung mit GCS < 15

E

- Temperatur < 35,0 Grad Celsius